

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
02/10/2023	02/10/2025	nº 02	SES.ENF nº 19	01 à 06
Nome do Procedimento: Cateterismo Vesical de Alívio				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária.				
Serviço: Unidade Básica de Saúde da Família, Serviços Especiais e Pronto Atendimento				
Executantes: Enfermeiros				
Objetivo: Orientar a padronização do procedimento de Cateterismo Vesical de Alívio na rede de Atenção à Saúde				
Recursos necessários: ✓ Prescrição médica; ✓ Luva estéril; ✓ Luva de procedimento; ✓ Bandeja de cateterismo vesical esterilizada: cuba rim, pinça, cuba redonda, gazes e campo; ✓ Mesa auxiliar; ✓ Sonda uretral; ✓ Cloridrato de lidocaína 2% - gel; ✓ 01 Seringa de 20ml <i>slip</i> (sem rosca); ✓ Gaze estéril; ✓ Clorexidina aquosa 2%; ✓ Frasco graduado; ✓ Água; ✓ Sabão; ✓ Papel toalha e/ou compressa; ✓ Biombo; ✓ Saco para lixo.				

Conceito

O cateterismo vesical é um procedimento estéril que consiste na introdução de uma sonda da uretra até a bexiga.

Indicação

- ✓ Esvaziar a bexiga de pacientes com retenção urinária, em preparo cirúrgico e mesmo no pós-operatório;
- ✓ Monitoramento do débito urinário;
- ✓ Determinação da urina residual com bexiga neurogênica que não possua um controle esfinteriano;
- ✓ Instilação de medicação;
- ✓ Obtenção de urina asséptica para exame laboratorial.

Contraindicações relativas

- ✓ História de estenose uretral;
- ✓ Reconstrução uretral prévia;

- ✓ Suspeita de lesão uretral (em situações de trauma ou lesão corto contuso com sinais de sangue no meato uretral, incapacidade aguda de urinar ou equimose e/ou edema perineal, escrotal ou peniana, deve-se descartar ruptura da uretra);
- ✓ Cirurgia urológica recente;
- ✓ Histórico de resistência na passagem de sonda vesical.

Complicações

- ✓ Lesão na uretra, próstata ou bexiga com sangramento;
- ✓ Infecção do trato urinário;
- ✓ Criação de falsos trajetos;
- ✓ Cicatrizes e estenoses uretrais;
- ✓ Parafimose.

DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO

Pré-inserção

- ✓ Revisar os registros do usuário, buscando a indicação do procedimento e a prescrição médica;
- ✓ Avaliar as condições do usuário: mobilidade, limitações físicas, nível de consciência, capacidade de compreensão e cooperação, padrão e última eliminação urinária, alterações geniturinárias, intercorrências ou alergias;
- ✓ Realizar prescrição de enfermagem de uma unidade de cloridrato de lidocaína 2% gel em nome do usuário em Prontuário Eletrônico para retirada na farmácia da UBSF;
- ✓ Reunir todo o material necessário;
- ✓ Organizar o material sobre uma bancada, mesa auxiliar ou superfície de apoio;
- ✓ Explicar o procedimento e a finalidade ao usuário e/ou acompanhante;
- ✓ Promover ambiente iluminado e privativo, podendo ser utilizado o biombo;
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Calçar a luva de procedimento;
- ✓ Posicionar o usuário em decúbito dorsal. Nos casos de usuária, posicioná-la em decúbito dorsal na posição de litotomia: pernas flexionadas, afastadas e calcanhares apoiados no leito;
- ✓ Realizar higiene com água e sabão na região perineal e do genital;
- ✓ Utilizar compressa ou pano limpo para secagem das regiões higienizadas;
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Abrir a bandeja de cateterismo vesical esterilizada;
- ✓ Adicionar gaze dentro da bandeja de cateterismo vesical se necessário;
- ✓ Abrir e colocar sobre o campo do kit de cateterismo vesical esterilizado os materiais: sonda uretral 12, 14 ou 16, de acordo com a indicação e característica do usuário e a seringa de 20 ml nos casos de cateterismo vesical masculino;
- ✓ Inserir a clorexidina aquosa 2% dentro da cuba redonda;
- ✓ Acrescentar o cloridrato de lidocaína 2% gel na cuba rim no cateterismo vesical feminino. Nos casos de cateterismo vesical masculino, colocar o cloridrato de lidocaína 2% gel na cuba rim e posteriormente aspirar o gel com a seringa de 20 ml (caso não tenha um profissional para auxiliar);
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Calçar as luvas estéreis;

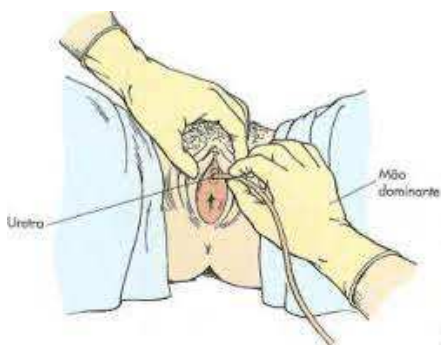
Sexo Feminino

- ✓ Realizar antisepsia da genitália, no sentido anteroposterior e lateral-medial com torundas de gaze embebidas com clorexidina aquosa 2%;
- ✓ Abrir suavemente os grandes e pequenos lábios e expor o meato uretral, usando a mão não

dominante, manter aberto até a introdução da sonda uretral;

- ✓ Realizar a antisepsia ao redor do meato uretral com movimento circular;
- ✓ Colocar o campo fenestrado estéril sobre a pelve de modo que a vulva permaneça exposta;
- ✓ Posicionar a cuba rim sobre o campo fenestrado, próximo a vulva;
- ✓ Segurar a sonda uretral com a mão dominante;
- ✓ Lubrificar a extremidade da sonda uretral com lidocaína gel 2%;
- ✓ Introduzir lentamente a sonda no meato uretral, de modo que a extremidade oposta da sonda fique dentro da cuba rim, e aguardar até o retorno da urina espontaneamente na cuba rim.

Figura 01 – Descritivo técnico antisepsia – feminina



Fonte: Potter, 2018

Sexo Masculino

- ✓ Segurar o pênis com a mão não dominante e retraindo o prepúcio;
- ✓ Realizar antisepsia da genitália com torundas de gaze embebidas com clorexidina aquosa 2%, com movimentos circulares ou perpendiculares, no sentido do prepúcio para a base do pênis;
- ✓ Realizar a antisepsia do meato uretral;
- ✓ Colocar o campo fenestrado estéril sobre a pelve de modo que o pênis permaneça exposto;
- ✓ Posicionar o pênis à 90° em relação ao corpo do paciente com a mão não dominante;
- ✓ Introduzir lidocaína gel 2% com a seringa lentamente no meato urinário com a mão dominante e comprimir o meato (com a mão não dominante) a fim de manter o Cloridrato de lidocaína 2% - gel dentro da uretra até a introdução da sonda;
- ✓ Introduzir com a mão dominante a sonda uretral, de modo que a extremidade oposta da sonda permaneça dentro da cuba rim, e aguardar a drenagem espontânea da urina.

Figura 02 – Descritivo técnico da passagem de sonda vesical – masculino



Fonte: Potter, 2018

Pós procedimento

- ✓ Aguardar a drenagem da urina total da urina na cuba rim, observar o volume total drenado e as características da urina;
- ✓ Em caso de drenagem volumosa de urina, de modo que seja necessário desprezar o conteúdo drenado antes do término da drenagem, o profissional deve fechar a extremidade da sonda, desprezar o conteúdo da cuba rim em frasco graduado, reposicionar a cuba rim, abrir a sonda novamente e reiniciar a drenagem;
- ✓ Ao final da drenagem, tracionar levemente a sonda uretral, observar se há algum resíduo de urina, e realizar leve compressão na região supra púbica (se possível, não realizar manobra em casos de lesões ou procedimento cirúrgico abdominal recente) ou solicitar que o usuário faça força para urinar;
- ✓ Retirar a sonda uretral lentamente;
- ✓ Desprezar todo o conteúdo da cuba rim no frasco graduado e aferir volume drenado;
- ✓ Auxiliar o usuário a se vestir e/ou coloque a fralda descartável;
- ✓ Recolher o material utilizado, e descartar conforme o Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 38);
- ✓ Retirar as luvas;
- ✓ Higienizar as mãos conforme Procedimento Operacional Padrão (POP – Rotina nº 23);
- ✓ Registrar o procedimento em Prontuário Eletrônico.

Novo Cateterismo e Intervalo de Procedimento

Não há um consenso técnico quanto ao intervalo entre cada drenagem, nos casos em que o usuário mantiver retenção ou indicação de drenagem via sonda, porém, em casos em que houver necessidade de drenagem de urina intermitente, deve-se avaliar o conteúdo drenado, objetivando uma drenagem máxima de 500 ml em cada procedimento para homens e 400 ml para mulheres.

Indica-se a sondagem vesical de alívio para usuário em que seja necessário a coleta de amostra, e não possuam continência adequada, para manter a amostra o menos contaminado possível. Para usuários do sexo masculino que necessitem amostra de urina, pode-se utilizar o coletor esterilizado de urina, sempre que houver condições de higiene, integridade da pele e cuidador ou profissional capacitado para colocação e retirada do coletor (o coletor deve ser trocado a cada 2 horas se não houver diurese espontânea, e realizado nova assepsia da pele antes da troca).

Nos casos de coleta de amostra, preferencialmente o primeiro jato deve ser desprezado na cuba rim, e coletado a porção intermediária da urina.

Para usuários com bexiga neurogênica ou outro distúrbio miccional permanente, deve sempre priorizar a auto sondagem ou sondagem por cuidador, quando a decisão for do usuário, reduzindo a possibilidade de contaminação cruzada, mesmo em instituição de saúde, salvo em casos de incapacidade motora.

OBSERVAÇÕES

- ✓ Interromper o procedimento nas seguintes situações:
 - Resistência significativa;
 - Considerar que a sonda está curvando-se na uretra;
 - Apresentar desconforto e/ou dor intensa;
 - Observar sangramento abundante;
 - Não houve drenagem da urina mesmo após confirmação do posicionamento e relato de sensação de bexiga cheia pelo usuário.
- ✓ O meato uretral feminino das idosas pode estar retraído em direção a entrada da vagina, devendo o profissional realizar inspeção prévia e tracionamento manual;
- ✓ A uretra masculina se curva contra o púbis, portanto, ao passar a sonda deve-se manter o pênis na posição vertical para reduzir a obstrução da curva;
- ✓ A drenagem da urina no cateterismo vesical masculino pode iniciar antes da sonda estar propriamente na bexiga;
- ✓ Deve-se descartar a sonda nas situações de introdução acidental na vagina;
- ✓ A bisnaga de cloridrato de lidocaína 2% gel ao final do procedimento deve ser desprezada para evitar contaminação cruzada;
- ✓ Em caso de incapacidade de finalizar o procedimento, o paciente deve ser encaminhado para serviço de referência em urologia ou cirurgia geral, para avaliação;
- ✓ Após o cateterismo, recomenda-se observar a eliminação espontânea da urina e anotar o horário, o volume e o aspecto da primeira micção espontânea;
- ✓ Usuários com necessidade de cateterismo residentes de Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI), devem ter o cuidado compartilhado com a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de referência. O procedimento pode ser realizado pela equipe de enfermagem da ILPI, porém, não isenta o acompanhamento, registros dos dispositivos e controle de infecção pela equipe da UBSF. O acompanhamento e manejo do idoso é de responsabilidade da equipe da UBSF, e a equipe da ILPI deve participar ativamente do cuidado;
- ✓ Nos casos de sondagem domiciliar, os materiais podem ser descartados na residência do usuário.

REFERÊNCIAS

1. BEZERRA, Carlos A., et. al. **Cateterismo Vesical Intermitente**: Indicações e Técnica. Portal da Urologia. 2015.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde**. Brasília – DF: 2017. Disponível em: <http://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/publicacoes/item/medidas-de-prevencao-deinfeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude>.
3. CARMAGNANI, Maria I.; FAKIH, Trevisani; CANTERAS, Lígia Mara Silva; TERERAN, N. **Procedimentos de Enfermagem** – Guia Prático, 2ª edição. Guanabara Koogan, 04/2017.
4. CHUNG, Paul H.; Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University. **Como fazer cateterismo uretral em um homem** – Distúrbios geniturinários. Manuais MSD edição para profissionais. 2020.
5. CHUNG, Paul H.; Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University. **Como fazer cateterismo uretral em uma mulher** - Distúrbios geniturinários. Manuais MSD edição para profissionais. 2020.
6. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA (Coren/SC). **Parecer Coren/SC nº 001/CT/2017**. Assunto: Cateterismo vesical de alívio (CVA) por pacientes ou familiares nas dependências de Unidades Hospitalares. Florianópolis – SC: 2017. Disponível: <https://www.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2017/01/Parecer-T%C3%A9cnico-001-2017-Cateterismo-Vesical-CT-M%C3%A9dia-e-Alta-Complexidade-2.pdf>
7. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES (EBSERH). **POP ENF 7.4**: terapia intravesical com bcg para tumor superficial de bexiga. Rio de Janeiro - RJ 2017.
8. Disponível em: https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hugg-unirio/aceso-a-informacao/documentos-institucionais/pops/urologia/pop-7-4_terapia-intravesical-com-bcg-para-tumor-superficial-de-bexiga.pdf
9. OLIVEIRA, Reynaldo G. **Blackbook Enfermagem**. Belo Horizonte – MG: 2016.
10. POTTER, P.A.; PERRY, A.G.; STOCKERT, P.; HALL, A. **Fundamentos de Enfermagem**. 9ªed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
11. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS). Serviço de Enfermagem em Saúde Pública. **Cateterismo Vesical Intermitente**: Manual de Orientações. Educação em Saúde, Vol 35. Hospital de Clínicas. Porto Alegre – SC: 2018.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2023 Fernanda Cristina Spiller	2023 Gabriela Cristina da Silva Brandão Manuelle Hölscher Belz	2023 Maristela Mello de Aguiar Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): 23.0.209571-0
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:Saúde

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	Jul/2023	Fernanda Cristina Spiller Manuelle Hölscher Belz	✓ Modificação do texto; ✓ Inclusão de informações específicas para coleta de amostra; ✓ Reorganização do texto; ✓ Atualização de conteúdo geral.

